

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESTIGMA INTERNALIZADO DE LA ENFERMEDAD MENTAL (ISMI-29)

Eje III: Personalidad • Evaluación Dimensional del Autoestigma y la Resistencia en Salud Mental

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI: 29 reactivos).
Nombre Original	Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI; Ritscher et al., 2003).
Autores Originales	Dra. Jennifer K. Ritscher (Boyd), Paul G. Otilingam y Michael Grajales (UCSF, EE. UU.).
Adaptaciones Hispanas	Bengochea-Seco et al. (2018), Rev. Psiquiatr. Salud Ment. ; Martín-Pérez et al., España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Identidad. Autoestigma, alienación y resistencia al estigma social.
Tipo de Instrumento	Autoinforme multidimensional de 29 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años) con diagnóstico o atención en salud mental.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación científica sin ánimo de lucro bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y DAÑO PSICOSOCIAL DEL AUTOESTIGMA

El **Estigma Internalizado o Autoestigma** (Corrigan et al., 2002; Ritscher et al., 2003) se define como el proceso subjetivo mediante el cual una persona diagnosticada de un trastorno mental incorpora los estereotipos y prejuicios sociales negativos circulantes sobre la enfermedad mental a su propia identidad personal, transformándolos en autodesprecio, anticipación de rechazo e indefensión aprendida (“efecto por qué intentar nada”).

El modelo multidimensional de la ISMI operacionaliza este fenómeno a través de cinco componentes estrechamente interconectados:

1. **Alienación:** La vivencia subjetiva de sentirse dañado, inferior o “menos que humano” debido al diagnóstico.
2. **Aprobación de Estereotipos:** El acuerdo consciente con falsas creencias populares sobre los trastornos psicológicos.
3. **Experiencia de Discriminación Percibida:** La percepción de trato injusto o condescendiente por parte del entorno.
4. **Retraimiento Social:** El aislamiento voluntario preventivo para evitar ser juzgado, rechazado o estigmatizado.
5. **Resistencia al Estigma:** Capacidad resiliente de autoafirmación positiva y rechazo de los prejuicios sociales (factor protector).

A nivel clinimétrico, el autoestigma elevado actúa como uno de los factores más devastadores en la cronificación psiquiátrica: correlaciona de forma crítica con baja adherencia psicofarmacológica, aislamiento ocupacional y elevado riesgo autolítico por pérdida radical de la esperanza existencial.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Subescala Factorial	Ítems (29)	Nº Ítems	Definición Operativa y Enfoque Evaluado
1. Alienación	1, 5, 8, 16, 17, 21	6 ítems	Sentirse defectuoso, arruinado, inferior y aislado del resto social.
2. Aprobación de Estereotipos	2, 6, 10, 13, 18, 23, 29	7 ítems	Convicción de que los enfermos mentales son violentos o inútiles.
3. Discriminación Percibida	3, 14, 22, 25, 28	5 ítems	Experiencias de rechazo, condescendencia y trato injusto sufrido.
4. Retraimiento Social	4, 9, 11, 15, 19, 24	6 ítems	Aislamiento social voluntario por vergüenza y miedo a ser descubierto.
5. Resistencia al Estigma (*)	7*, 12*, 20*, 26*, 27*	5 ítems	Orgullo identitario, asertividad y rechazo activo del prejuicio ajeno.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la validación española de Bengochea-Seco et al. (2018; N = 267): coeficiente alfa de Cronbach de 0.91 global; Alienación = 0.84; Aprobación de Estereotipos = 0.76; Discriminación = 0.77; Retraimiento = 0.81; Resistencia = 0.71. Coeficiente omega global = 0.92. Fiabilidad test-retest $r = 0.85$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica el modelo jerárquico de cinco factores de primer orden subordinados a un factor general de Estigma Internalizado (CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.052).
Validez Concurrente	Correlación directa intensa con Depresión (BDI-II, $r = 0.59$), Desesperanza de Beck (BHS, $r = 0.54$) y Ansiedad Social (LSAS, $r = 0.48$). Correlación inversa profunda con Autoestima (RSES, $r = -0.64$), Autoeficacia (GSE, $r = -0.55$) y Calidad de Vida (WHOQOL, $r = -0.58$).
Sensibilidad al Tratamiento	Sensibilidad acreditada en programas de desestigmatización grupal (ej. Honest, Open, Proud - HOP / Narrative Enhancement and Cognitive Therapy - NECT), mostrando reducciones significativas de $d > 0.60$ postintervención.
Invarianza Diagnóstica	Invarianza de medida ratificada entre pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor recurrente.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 29 ítems se responde en una escala tipo Likert de 4 alternativas:

- **Opciones de Calificación:** 1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «De acuerdo», 4 = «Totalmente de acuerdo».
- **Paso 1 (Inversión de la Subescala de Resistencia al Estigma):** Los 5 reactivos de Resistencia (**ítems 7, 12, 20, 26 y 27**) **deben invertirse**:

$$\text{Ítem Invertido} = 5 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 1 pasa a 4; 2 pasa a 3; 3 pasa a 2; 4 pasa a 1).

- **Paso 2 (Puntuación Media Total ISMI):** Se promedian los 29 ítems (con los 5 de Resistencia ya invertidos):

$$\text{Puntuación Media ISMI} = \frac{1}{29} \sum_{i=1}^{29} \text{Ítem}_i$$

(Rango: **1.00 a 4.00 puntos**).

- **Medias por Subescala:** Se calcula la media sumando los reactivos correspondientes y dividiendo entre el número de ítems de cada factor.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA SEGÚN BOYD (MEDIA 1.00 A 4.00)

Estratificación	Media Global	Nivel de Autoestigma	Interpretación y Recomendación Clínica
Nulo / Mínimo	1.00 a 2.00 pts	Sin estigma internalizado	Identidad preservada; alta resistencia y dignidad personal. Pronóstico muy favorable.
Leve	2.01 a 2.50 pts	Autoestigma leve	Incomodidad o vergüenza ocasional sin interferencia ocupacional grave. Psicoeducación.
Moderado	2.51 a 3.00 pts	Autoestigma manifiesto	Sentimientos frecuentes de inferioridad y retraimiento social. Terapia desestigmatizante.
Severo Grave	/ 3.01 a 4.00 pts	Autoestigma severo (≥ 3.01)	Alienación extrema, desamparo y aislamiento radical. Foco clínico prioritario.

ALERTA DE DESESPERANZA Y SUICIDIO (CORTE ISMI ≥ 2.51):

Un ISMI ≥ 2.51 predice un riesgo 3 veces superior de ideación autolítica en pacientes con patología psiquiátrica. El paciente asume que su vida "está arruinada para siempre por culpa de la enfermedad", perdiendo la motivación para continuar el tratamiento psicoterapéutico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DESESTIGMATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN NARRATIVA (NECT)

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD LIBRE DE ESTIGMA:

- **Paso 1 (Psicoeducación Crítica):** Desmontar los mitos asociados a la etiqueta psiquiátrica mediante datos científicos objetivos. Separar categóricamente la identidad del paciente de su diagnóstico ("tienes un trastorno, no eres un trastorno").
- **Paso 2 (Reestructuración Narrativa de la Historia de Vida - NECT):** Reeditar la narrativa personal del paciente para incorporar fortalezas, metas y logros personales previos y posteriores al debut clínico.
- **Paso 3 (Entrenamiento en Decisión de Revelación - HOP):** Enseñar habilidades para decidir a quién, cuándo y cómo compartir el diagnóstico de salud mental, evitando tanto el secretismo avergonzado como la sobreexposición imprudente.
- **Paso 4 (Criterio de Recuperación):** Un descenso en la media de ISMI a ≤ 2.00 y un incremento en Resistencia al Estigma consolidan la resiliencia cívica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ESQUIZOFRENIA ESTABILIZADA CON AUTOESTIGMA

Identificación: Varón de 27 años con diagnóstico de psicosis no orgánica en remisión sintomática completa desde hace 14 meses con antipsicóticos de segunda generación. Acude remitido por su psiquiatra debido a reclusión total en el domicilio paterno, abandono de amistades y rechazo a buscar trabajo ("los esquizofrénicos somos una carga inútil para la sociedad").

Evaluación Inicial ISMI (Línea Base): Media Global = **3.24/4.00** (Autoestigma Severo). Alienación = **3.67/4.00**; Retraimiento Social = **3.83/4.00**; Aprobación de Estereotipos = **3.14/4.00**; Resistencia al Estigma = **1.40/4.00** (ausencia de orgullo y autodefensa).

Plan Terapéutico: 16 sesiones individuales y grupales basadas en NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy). Se desafió la creencia de incompetencia laboral, conectándole con el programa de inserción laboral protegida de salud mental comunitaria.

Reevaluación a los 5 Meses: Media Global ISMI descendió a **1.89/4.00** (-1.35 pts, rango Sin Autoestigma); Resistencia al Estigma aumentó a **3.60/4.00**. El paciente comenzó a trabajar a media jornada en un centro documental y retomó actividades deportivas sin ocultar su necesidad de medicación.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AUTOESTIGMA Y RIESGO SUICIDA INMINENTE:

En pacientes recién diagnosticados de trastorno bipolar o esquizofrenia, un ISMI > 3.00 es una bandera roja mayor de suicidio post-alta hospitalaria ("muerte social anticipada"). Monitorizar con C-SSRS y red familiar.

AUTOESTIGMA VS. SÍNTOMAS NEGATIVOS:

Diferenciar el Retraimiento Social secundario a vergüenza estigmatizante (ISMI) de la abulia o aplanamiento afectivo primario por síntomas negativos de la psicosis (evaluar mediante la escala PANSS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ritsher, J. B., Otilingam, P. G., & Grajales, M. (2003). Internalized stigma of mental illness: Psychometric properties of a new measure. *Psychiatry Research*, 121(1), 31-49.
2. Bengochea-Seco, R., Arrieta-Rodríguez, M., & Sánchez-Gutiérrez, T. (2018). Adaptación y validación española de la Escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI). *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 11(4), 218-228.
3. Boyd, J. E., Adler, E. P., Otilingam, P. G., & Peters, T. (2014). Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale: A review of its properties and findings. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 23(1), 17-29.
4. Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). The paradox of self-stigma and mental illness. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 9(1), 35-53.